

Dermatitis de Contacto (Irritativa y Alérgica)

1. Introducción y relevancia clínica

La **dermatitis de contacto (DC)** es una reacción inflamatoria cutánea **inducida por la exposición directa a sustancias externas**, que puede ser **irritativa o alérgica** según su mecanismo fisiopatológico.

Constituye una de las **causas más frecuentes de consulta dermatológica en adultos** y representa un problema importante en **medicina laboral y de atención primaria**.

En Chile, las dermatitis de contacto ocupan un lugar relevante en **enfermedades profesionales**, especialmente en trabajadores sanitarios, peluqueros, manipuladores de alimentos y personal industrial.

Su **reconocimiento clínico y diferenciación** de otras dermatitis (atópica, seborreica) es esencial para el EUNACOM y la práctica clínica general.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Existen **dos tipos principales de dermatitis de contacto**:

2.1. Dermatitis de contacto irritativa (DCI)

- Es la **forma más común (≈80%)**.
- Se debe a **daño directo de la barrera cutánea** por agentes químicos o físicos (jabones, detergentes, ácidos, solventes).
- **No requiere sensibilización previa**.
- La severidad depende de la concentración del irritante, tiempo de exposición y susceptibilidad individual.
- Mecanismo: daño del estrato córneo → pérdida de agua → inflamación local no inmunológica.

2.2. Dermatitis de contacto alérgica (DCA)

- Es una **reacción de hipersensibilidad tipo IV (tardía, mediada por linfocitos T)**.

- Requiere una **fase de sensibilización previa** (días a semanas).
 - La reexposición genera respuesta inflamatoria localizada.
 - Agentes frecuentes: níquel, cromo, fragancias, cosméticos, anestésicos tópicos, antibióticos (neomicina), formaldehído, caucho (látex).
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones comunes

- Eritema, edema, vesículas, exudado y prurito.
 - En casos crónicos: **descamación, fisuras, liquenificación**.
 - Distribución **limitada al área de contacto**, aunque puede extenderse.
-

3.2. Dermatitis de contacto irritativa (DCI)

Características clínicas

- **Inicio rápido (horas)** tras la exposición.
- Afecta **áreas expuestas directamente** al agente (manos, antebrazos, cara).
- Puede ser **aguda (una exposición intensa)** o **crónica (contactos repetidos)**.
- Prurito variable, más **ardor o dolor** que picazón.

Ejemplos clínicos comunes

- Lavado excesivo de manos con detergentes o alcohol gel.
 - Exposición ocupacional a disolventes, cemento, cloro o ácidos.
 - “Dermatitis del pañal” en lactantes (forma irritativa).
-

3.3. Dermatitis de contacto alérgica (DCA)

Características clínicas

- **Inicio 24–72 h post exposición.**
- Prurito intenso y lesiones eccematosas en el sitio de contacto.
- Puede extenderse **más allá del área de exposición.**
- Lesiones agudas: eritema, vesículas, exudado.
- Lesiones crónicas: liquenificación, hiperpigmentación.

Ejemplos comunes

- **Níquel:** aros, relojes, hebillas, botones.
- **Fragancias / cosméticos:** dermatitis facial o cervical.
- **Anestésicos tópicos:** dermatitis post-aplicación de lidocaína o benzocaína.
- **Látex:** guantes sanitarios, con posibilidad de reacción mixta (alérgica + irritativa).
- **Neomicina o bacitracina:** dermatitis post-aplicación de antibióticos tópicos.

3.4. Distribución típica según causa

Localización	Agente sospechoso
Manos	Jabones, detergentes, látex, cemento
Cara / cuello	Cosméticos, perfumes, tintes capilares
Pies	Calzado (cromo, goma, adhesivos)
Abdomen inferior	Hebilla de cinturón (níquel)

Axilas	Desodorantes, fragancias
--------	--------------------------

Párpados	Cosméticos, esmaltes de uñas (transferencia manual)
----------	---

3.5. Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencias clave
Dermatitis atópica	Curso crónico, antecedentes familiares, piel seca generalizada
Dermatitis seborreica	Escamas amarillentas, localización en cuero cabelludo y pliegues nasogenianos
Psoriasis	Placas bien delimitadas, descamación gruesa plateada
Escabiosis	Prurito nocturno, surcos interdigitales
Micosis	Bordes activos, descamación circular (confirmar con KOH)

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El **diagnóstico es clínico**, basado en la historia de exposición y morfología de las lesiones.

4.1. Historia clínica orientadora

- Identificar **sustancia sospechosa**, tipo de trabajo o cosméticos usados.
- Evaluar **tiempo de exposición, localización y recurrencia**.
- Si hay otros afectados en el entorno (ocupacional o familiar).

4.2. Pruebas diagnósticas

Examen	Utilidad	Interpretación
Test de parche (Patch Test)	Diagnóstico de DCA (no útil en DCI)	Positivo si eritema, pápulas o vesículas en el sitio de aplicación a las 48–96 h
Biopsia cutánea	Casos dudosos	Espongiosis con infiltrado linfocítico perivascular
Examen micológico (KOH)	Diferenciar de tiñas o candidiasis	Negativo en DC

Criterios diagnósticos:

1. Relación temporal entre exposición y aparición de lesiones.
2. Lesiones localizadas al área de contacto.
3. Resolución al evitar el agente.
4. Positividad del test de parche (en DCA).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento tiene tres pilares:

1. **Evitar el agente causal.**
2. **Reparar la barrera cutánea.**
3. **Controlar la inflamación y el prurito.**

5.1. Medidas generales

- Identificar y **suspender exposición** al agente sospechoso.
- Uso de **guantes de vinilo o nitrilo** (evitar látex en casos alérgicos).
- Empleo frecuente de **emolientes** sin perfume.
- Jabones neutros o syndets.
- Evitar agua muy caliente, solventes o fricción excesiva.

5.2. Tratamiento farmacológico

Tipo / severidad	Tratamiento	Duración / observaciones
Leve – localizada	Corticoide tópico de potencia baja a media (hidrocortisona 1%, mometasona, betametasona valerato) 1–2 veces/día	7–10 días
Moderada – extensa	Corticoide tópico + emolientes; antihistamínico oral (loratadina, cetirizina)	Hasta remisión
Grave o resistente	Corticoide sistémico corto (prednisona 0.5 mg/kg/día × 5–7 días) o inhibidor de calcineurina (tacrolimus/pimecrolimus)	Bajo supervisión dermatológica
Infección secundaria (impetiginización)	Antibióticos tópicos (mupirocina) o VO (cefalexina 7–10 días)	Cultivar si recidiva
Prurito severo nocturno	Antihistamínicos sedantes (hidroxicina, difenhidramina)	Uso corto

5.3. Tratamiento específico por tipo

Dermatitis irritativa

- Suspender agente y aplicar **emoliente + corticoide tópico suave**.
- En casos crónicos (manos de trabajadores): educación laboral, guantes protectores y cremas barrera (dimeticona, glicerina).

Dermatitis alérgica

- Evitar reexposición a alérgeno identificado por test de parche.
- Corticoides tópicos medianos o potentes según zona.
- En recaídas recurrentes: considerar **fototerapia UVB banda estrecha** o inmunomoduladores tópicos (tacrolimus, pimecrolimus).

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Causa	Manejo
Eccema crónico o liquenificación	Exposición persistente o rascado crónico	Corticoides tópicos, fototerapia
Sobreinfección bacteriana (impétigo)	<i>S. aureus</i> secundario a excoriación	Antibióticos tópicos o VO
Dermatitis ocupacional	Exposición laboral continua	Prevención y educación
Dermatitis sistémica alérgica	Absorción del alérgeno (níquel, medicamentos)	Evitación y manejo sistémico

Pronóstico:

Excelente si se evita el agente causal.

Las formas crónicas irritativas pueden persistir o exacerbarse ante mínima exposición.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Inicio rápido tras exposición → DCI; inicio diferido (1–3 días) → DCA.**
 2. En DCA, el **prurito es el síntoma dominante**; en DCI predomina el **ardor o escozor**.
 3. La **distribución limitada al área de contacto** orienta fuertemente el diagnóstico.
 4. **Test de parche positivo → confirma DCA.**
 5. En dermatitis de manos ocupacional, el agente más común es **jabones/detergentes** (irritativo).
 6. **Níquel** es el alérgeno más frecuente en mujeres (aros, relojes, botones).
 7. La base del tratamiento es la **evitación del agente + corticoides tópicos + emolientes**.
-



Errores comunes

- Usar antibióticos tópicos prolongadamente → sensibilización secundaria.
 - Diagnosticar erróneamente dermatitis de contacto sin historia clara de exposición.
 - No investigar alergia a níquel en lesiones recurrentes en abdomen o lóbulos.
 - Aplicar corticoides potentes en cara o párpados → atrofia.
 - No recomendar medidas preventivas en trabajadores (uso de guantes, cremas barrera).
 - Confundir dermatitis irritativa con infección fúngica o eczema atópico.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **dermatitis de contacto** es una inflamación cutánea por agentes externos, **irritativa (80%)** o **alérgica (20%)**.
2. **DCI**: daño directo sin sensibilización; **DCA**: hipersensibilidad tipo IV con exposición previa.
3. El **diagnóstico es clínico**, confirmado con **test de parche** en DCA.
4. **Evitar el agente causal** y **usar corticoides tópicos + emolientes** son las medidas centrales.
5. En DCI predomina el **ardor** y aparece rápidamente; en DCA, el **prurito intenso** y el inicio es tardío.
6. El **níquel** es el alérgeno más común; los **detergentes**, la causa más frecuente de DCI.
7. En EUNACOM, la clave diagnóstica es: **lesión pruriginosa en área de contacto con metal o cosmético → DCA**.